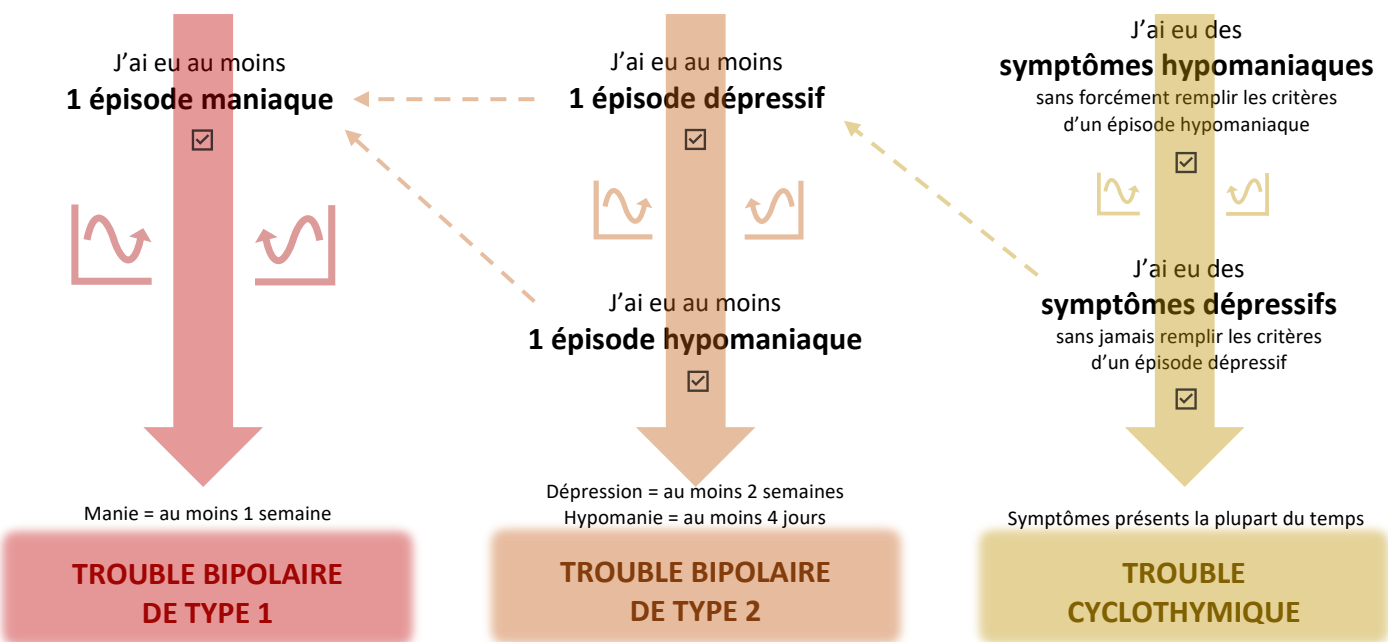
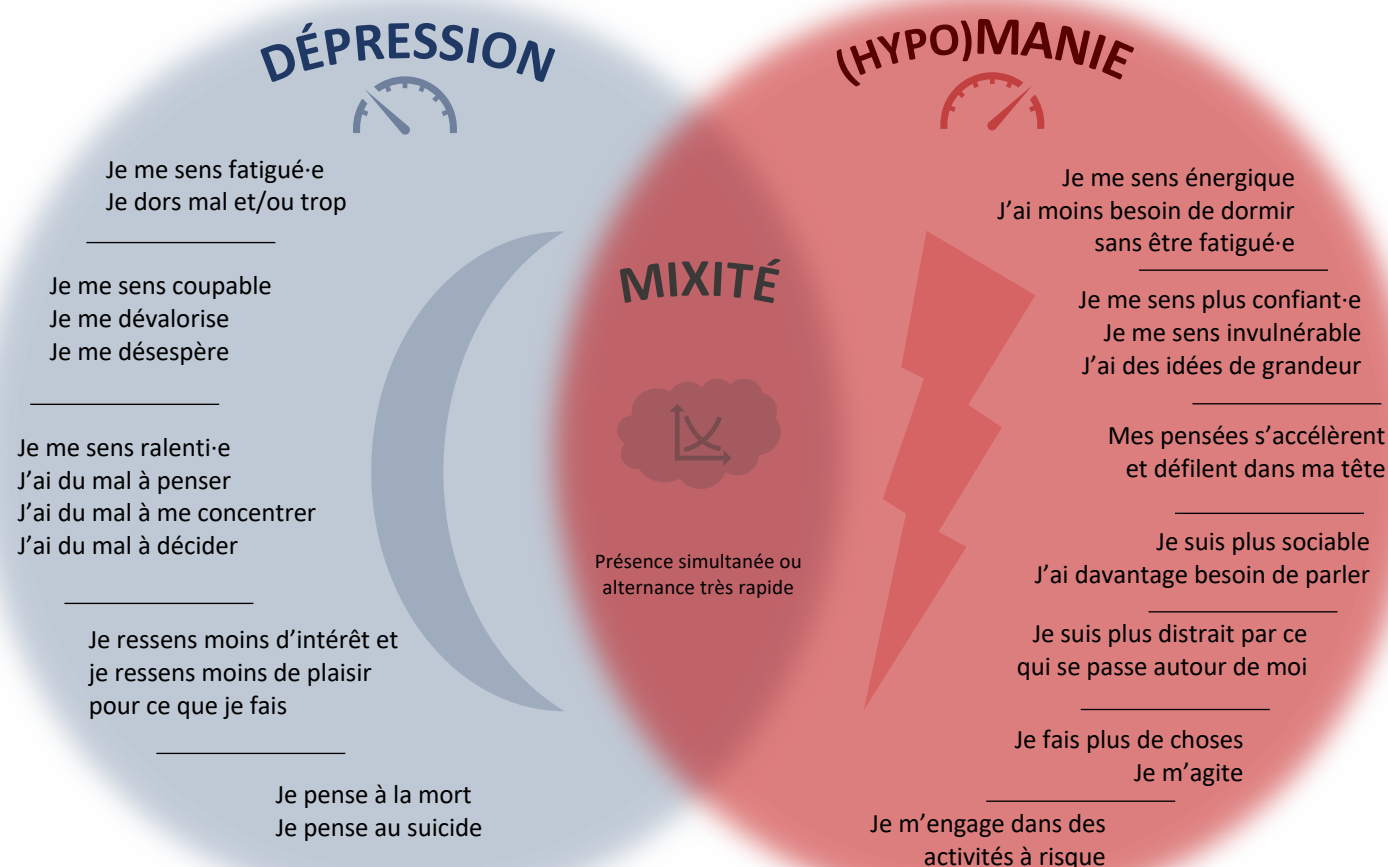


LE TROUBLE BIPOLAIRE

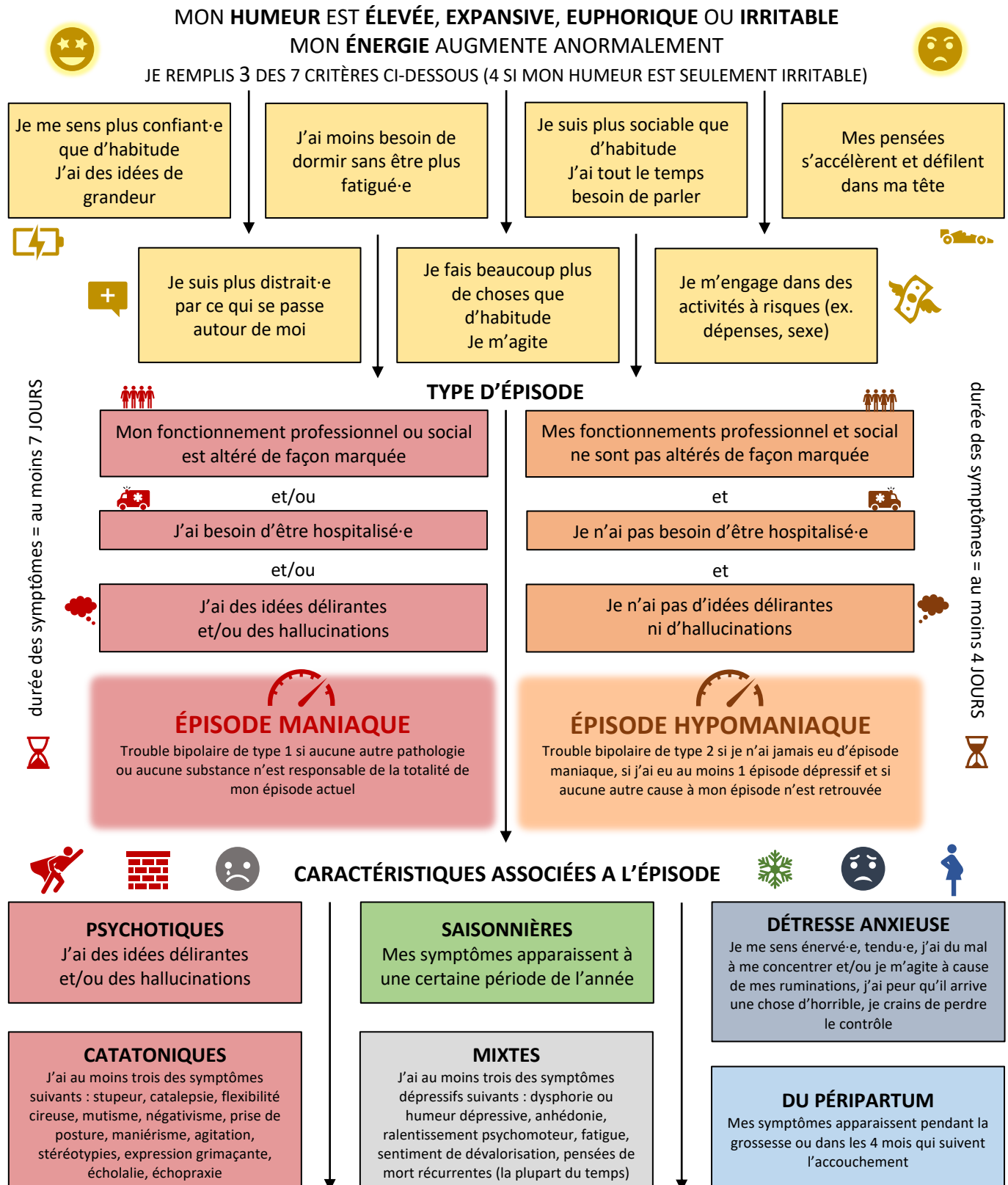
Le trouble bipolaire est défini par des épisodes et/ou des symptômes (hypo)maniaques et/ou dépressifs dont la récurrence varie selon la forme de bipolarité. Les types 1 et 2 réunis concernent environ 1% de la population tandis qu'une prise en compte plus globale du spectre de la bipolarité conduit à doubler voire tripler ce pourcentage. Ce trouble, dont la composante génétique n'est pas négligeable, débute généralement chez l'adulte jeune (15 à 25 ans) et figure parmi les pathologies les plus invalidantes selon l'OMS. Le taux de suicide est important et le retard au diagnostic reste préoccupant.



L'ÉPISODE (HYPO)MANIAQUE

SYMPTÔMES ET SOUS-TYPES

Contrairement à celle de la dépression, l'humeur de la manie est anormalement élevée, expansive ou irritable, ceci de façon persistante sur une période délimitant un épisode. Cette humeur particulière s'accompagne d'une augmentation toute aussi anormale et persistante de l'énergie et de l'activité, que cette dernière soit ou non orientée vers un but. Plusieurs substances (intoxication ou sevrage) ou pathologies peuvent favoriser l'apparition ou le maintien des symptômes (hypo)maniaques ainsi que des caractéristiques associées.

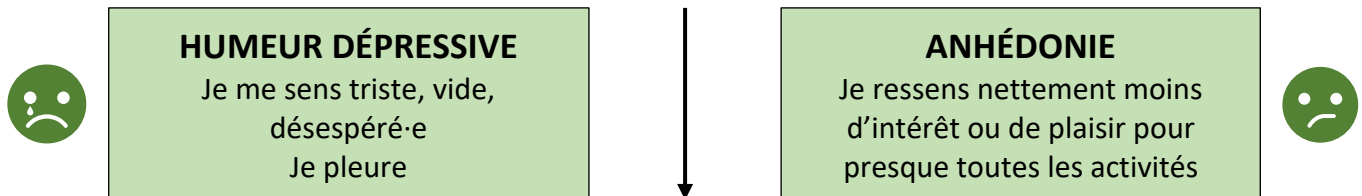


LA DÉPRESSION

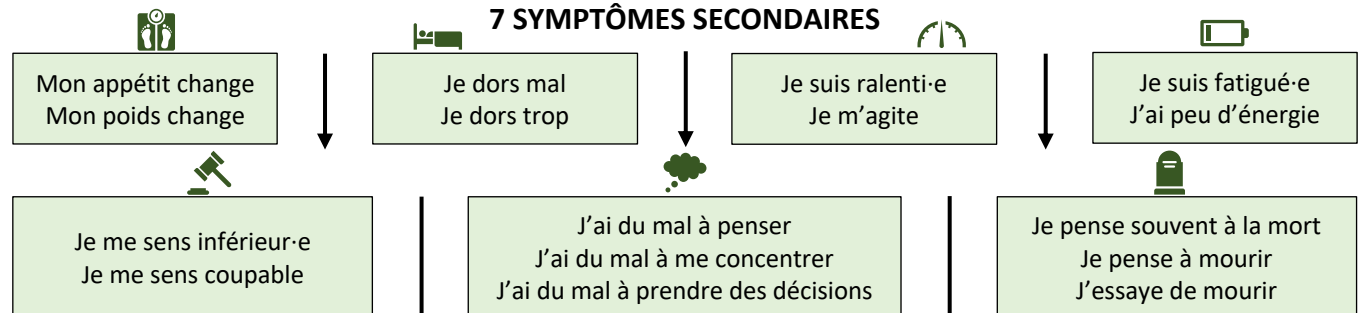
SYMPTÔMES ET SOUS-TYPES

Les troubles dépressifs sont caractérisés par une humeur dépressive (se sentir triste, vide ou sans espoir) et/ou une perte de plaisir accompagnée d'autres symptômes cognitifs, comportementaux ou neurovégétatifs qui affectent de manière significative la capacité de fonctionnement de la personne concernée. Parmi les premières causes d'incapacité dans le monde, la dépression touche environ 5% de la population adulte avec une prédominance chez la femme. Aigue ou chronique, de sévérité variable, elle peut conduire jusqu'au suicide, récidive fréquemment et peut parfois révéler un trouble bipolaire.

2 SYMPTÔMES PRIMAIRES



7 SYMPTÔMES SECONDAIRES



2 TYPES DE DÉPRESSION

Suis-je dans mon état habituel ?

NON = DÉPRESSION AIGUE

Rupture avec le fonctionnement antérieur

TR Trouble Dépressif Caractérisé

(= épisode dépressif majeur)

Au moins 5 SYMPTÔMES

parmi lesquels HUMEUR DÉPRESSIVE et/ou ANHÉDONIE

Quasiment TOUTE LA JOURNÉE et presque TOUS LES JOURS

Pendant au moins 2 SEMAINES

OUI = DÉPRESSION CHRONIQUE

Pas de rupture avec le fonctionnement antérieur

TR Trouble Dépressif Persistant

(= dysthymie)

Au moins 3 SYMPTÔMES

parmi lesquels HUMEUR DÉPRESSIVE

Quasiment TOUTE LA JOURNÉE et plus d'UN JOUR SUR DEUX

Pendant au moins 2 ANS

CARACTÉRISTIQUES

Suis-je encore sensible aux choses agréables ?

NON = anesthésie affective

OUI = les événements positifs améliorent mon humeur

MÉLANCOLIQUES

Je me réveille très tôt
Je me sens plus mal le matin
Je suis très ralenti-e ou très agité-e
Je perds l'appétit et du poids
Je me sens coupable et désespéré-e

ATYPIQUES

Je prends de l'appétit et du poids
Je dors beaucoup plus
J'ai des sensations de lourdeur
Je suis très sensible au rejet

MIXTES

J'ai au moins 3 des symptômes (hypo)maniaques suivants : humeur élevée, augmentation de l'estime de soi, désir de parler constamment, fuite des idées, augmentation de l'énergie, activités à risques, réduction du besoin de sommeil.

CATATONIQUES

J'ai au moins trois des symptômes suivants : stupeur, catalepsie, flexibilité cireuse, mutisme, négativisme, prise de posture, maniérisme, agitation, stéréotypies, expression grimaçante, écholalie, échopraxie.

ANXIEUSES

Je me sens énervé-e, tendu-e, j'ai du mal à me concentrer et/ou je m'agite à cause de mes ruminations, j'ai peur qu'il arrive une chose d'horrible, je crains de perdre le contrôle.

PSYCHOTIQUES

J'ai des hallucinations et/ou des idées délirantes (congruentes si en rapport avec culpabilité, maladie, mort, nihilisme, punition méritée ou inadéquation personnelle).

L'ÉPISODE (HYPO)MANIAQUE

SYMPTÔMES ET SOUS-TYPES

Contrairement à celle de la dépression, l'humeur de la manie est anormalement élevée, expansive ou irritable, ceci de façon persistante sur une période délimitant un épisode. Cette humeur particulière s'accompagne d'une augmentation toute aussi anormale et persistante de l'énergie et de l'activité, que cette dernière soit ou non orientée vers un but. Plusieurs substances (intoxication ou sevrage) ou pathologies peuvent favoriser l'apparition ou le maintien des symptômes (hypo)maniaques ainsi que des caractéristiques associées.

